延续护理对糖尿病足患者自我管理能力、血糖指标的影响

季丛清
226001 南通大学附属医院分院内分泌科，江苏 南通

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2023.28.044

摘　要　目的：探讨延续护理对糖尿病足患者自我管理能力、血糖指标的影响。方法：选取2020年1月—2021年8月南通大学附属医院分院收治的190例糖尿病足患者作为研究对象，根据随机数字表法分为观察组及对照组，各95例。对照组实施常规护理，观察组实施延续护理。比较两组自我管理能力、血糖指标。结果：出院后1年，对照组血糖控制水平管理、足部及日常生活管理、病情监测管理评分低于出院时，观察组各项评分高于对照组，差异有统计学意义($P < 0.001$)。出院后1年，对照组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白水平高于出院时，观察组低于对照组，差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论：延续护理可提高糖尿病患者自我管理能力，有效控制血糖指标。

关键词　糖尿病足；延续护理；自我管理行为；血糖；并发症

Effect of Continuous Nursing Care on Self-management Ability and Blood Glucose Index of Diabetic Foot Patients

Ji Congqing
The branch Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu Province, China

Abstract　Objective: To explore the effect of continuous nursing care on self-management ability and blood glucose index of diabetic foot patients. Methods: A total of 190 diabetic foot patients were selected as the study objects at the Affiliated Hospital of Nantong University from January 2020 to August 2021, and were divided into observation group and control group according to random number table method, with 95 cases in each group. The control group received routine nursing, and the observation group received continuous nursing. Self-management ability and blood glucose index were compared between the two groups. Results: One year after discharge, the scores of blood glucose control level management, foot and daily life management, and disease monitoring management in the control group were lower than those at discharge, and the scores in the observation group were higher than those in the control group, and the difference was statistically significant ($P < 0.001$). One year after discharge, the levels of fasting blood glucose, 2 h postprandial blood glucose and glycosylated hemoglobin levels in the control group were higher than those at discharge, and those in the observation group were lower than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P < 0.05$). Conclusion: Continuous nursing can improve the self-management ability of diabetic patients and effectively control blood glucose index.

Key words　Diabetic foot; Continuous nursing; Self-management ability; Blood glucose; Complication

糖尿病足是糖尿病患者最为常见且严重的并发症，主要表现为肌肉萎缩、皮肤干燥、间歇性跛行、足部疼痛等，若诊治不及时，则易致残，对患者的生活质量及身心健康造成严重影响[1-2]。出院患者及照顾者大部分缺乏足部护理知识，导致其健康护理依从性差，因此应增强患者及照护理者对糖尿病足的防范意识，提高自我护理能力。提供长期且持续性的护理服务，加强糖尿病患者出院后的护理尤为重要。延续护理是以患者为中心的护理模式，使患者出院后也能接受科学的护理干预。本研究旨在分析延续护理对糖尿病足患者自我管理能力、血糖指标的影响，现报告如下。

资料与方法

选取2020年1月—2021年8月南通大学附属医院分院收治的190例糖尿病足患者作为研究对象，根据随机数字表法分为观察组及对照组，各95例。观察组男49例，女46例；年龄54～96岁，平均(74.22±13.22)岁；糖尿病足病程1～11年，平均(5.23±2.05)年。观察组男47例，女48例；年龄55～98岁，平均(75.02±12.27)岁；糖尿病足病程2～10年，平均(5.76±2.11)年。两组患者一般资料比较，差异无统计学意义($P > 0.05$)，具

有可比性。患者均对本研究内容知情同意。

纳入标准：①年龄≥18岁；②符合糖尿病足诊断标准[3]；③可正常沟通。

排除标准：存在其他重大疾病者；合并抑郁、认知功能障碍者。

方法：对照组实施常规护理，包括口头告知患者疾病知识，叮嘱患者按时用药及检查、定期来医院复查等。观察组实施延续护理。①组建延续性护理小组：由糖尿病专科护士与主管护师等组成延续护理小组，通过培训提高组员的沟通能力等职业素养，使其充分了解延续护理的宗旨与方法。小组成员共同协商开展延续护理的服务工作，及时评估护理成效，调整护理计划。②建立患者健康档案：收集、汇总患者资料，包括病情、足部皮肤状态、疾病认知情况、家庭住址、联系方式等。实时跟踪患者的病情进展。③延续护理方式：a.电话随访，1次/周，评估患者执行延续护理的实际情况，及时指导和纠正错误或不当行为。b.家庭随访，2个月随访1次，护理内容涉及运动锻炼、饮食控制、监测血糖、讲解疾病知识，促使患者了解自身疾病，积极主动地配合相关护理工作。c.定期开展健康讲座，把糖尿病足相关知识编制成册，免费发放给患者，宣传健康知识；鼓励病友之间交流疾病康复经验，列举既往治疗成功的案例，帮助患者建立战胜疾病的信心。d.建立战胜微信群，定时在群内发送糖尿病足治疗及预防知识。④完善糖尿病足护理内容：a.健康知识教育，主要宣教糖尿病知识，糖尿病足含义、危害、症状及足部护理等知识。b.饮食指导，规划患者饮食方案，注重饮食中糖及脂肪的含量，保证蔬菜的摄入量，保证营养均衡。c.心理护理，因社会活动减少，社会角色的改变，患者很容易产生孤独感、失落感甚至恐惧感。护理人员应多与患者交流，给患者心理疏导和心理支持，安慰、鼓舞患者，帮助患者树立战胜疾病的信心，使患者积极配合治疗。d.加强足部护理，每天用37～40 ℃温水清洗足部，10 min/次，洗完用毛巾擦干；用润肤膏涂抹足部，保持皮肤湿润，以防皲裂；由脚尖位置向下肢进行按摩，5 min/次，早晚各1次。足部护理期间应密切监测血糖水平并严格控制；鼓励患者每天做抬脚尖、弯腰动作，促进下肢血液循环；叮嘱患者定期复诊。

观察指标：①自我管理能力：采用糖尿病足患者自我管理行为量表评估，包括血糖控制水平管理、足部及日常生活管理、病情监测管理3个维度，共16个项目，采用Liker 4级评分法，分值1～4分，总分16～64分，得分与自我管理能力呈正相关[4]。②血糖指标：采用日立7600全自动生化分析仪，根据葡萄糖氧化酶法检测空腹血糖及餐后2 h血糖；采用深圳迈瑞H50糖化血红蛋白分析仪，根据高效液相色谱法检测糖化血红蛋白水平。

统计学方法：数据应用SPSS 23.0统计学软件分析；计数资料以n(%)表示，采用χ^2检验；计量资料以$\bar{x}\pm s$表示，采用t检验；$P<0.05$表示差异有统计学意义。

结　果

两组自我管理能力评分比较：出院时，两组血糖控制水平管理、足部及日常生活管理、病情监测管理评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；出院后1年，对照组血糖控制水平管理、足部及日常生活管理、病情监测管理评分低于出院时，观察组各项评分高于对照组，差异有统计学意义($P<0.001$)。见表1。

两组血糖指标比较：出院时，两组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白水平比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；出院后1年，对照组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白水平高于出院时，观察组低于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。见表2。

表1　两组自我管理能力评分比较($\bar{x}\pm s$，分)

组别	n	血糖控制水平管理		足部及日常生活管理		病情监测管理	
		出院时	出院后1年	出院时	出院后1年	出院时	出院后1年
对照组	95	55.75±3.45	42.20±7.44*	56.68±3.67	43.11±8.50*	57.66±3.62	42.12±8.25*
观察组	95	55.22±3.38	54.80±3.60	56.27±4.02	55.60±5.35	57.38±3.45	56.80±4.02
t		1.110	14.859	0.734	12.121	0.546	15.591
P		0.268	<0.001	0.464	<0.001	0.586	<0.001

注：与本组出院时比较，*$P<0.001$

表2 两组血糖指标比较($\bar{x}\pm s$)

组别	n	空腹血糖(mmol/L)		餐后2 h血糖(mmol/L)		糖化血红蛋白(%)	
		出院时	出院后1年	出院时	出院后1年	出院时	出院后1年
对照组	95	5.83±1.45	6.80±1.78*	7.65±1.72	8.98±1.95*	6.45±1.18	6.89±1.22*
观察组	95	5.70±1.52	5.90±1.48	7.80±1.68	8.11±1.97	6.36±1.20	6.50±1.08
t		0.665	3.789	0.609	3.059	0.521	2.931
P		0.507	< 0.001	0.543	0.003	0.603	0.004

注：与本组护理前比较，*$P < 0.05$

讨 论

糖尿病是我国常见且高发的一种慢性内分泌代谢性疾病，血糖长期处于高水平状态可损伤周围血管及神经，患者如不注意足部护理，易诱发糖尿病足[5]。糖尿病足是指在糖尿病神经和(或)血管病变的基础上出现足部感染、溃疡和(或)深层组织破坏，表现为足部皮肤干燥、无汗，足部感觉迟钝、溃疡、坏疽，不仅严重影响患者日常活动，还可能导致创口难以愈合，甚至导致截肢[6]。有研究表明，> 50%的糖尿病患者对糖尿病足缺乏正确的认知，足部护理行为不良是导致糖尿病足患者截肢的主要原因[7]。良好的护理服务有利于积极预防和控制患者疾病进展。

延续护理打破了时间、空间的限制，不但在患者住院期间提供优质的医疗服务，出院后也可为患者提供有效护理，提高其疾病知识掌握程度，从而更好地控制疾病发展，提高生活质量。延续性护理以患者为中心，通过组建延续性护理小组，统筹安排，保证护理工作的有序实施。通过建立健康档案等方式，可及时了解患者运动、用药与饮食等自我护理情况，对制定与调整个体化的糖尿病足护理方案有指导意义。通过电话随访、家庭访视、定期组织讲座等方法，多渠道向患者传授糖尿病足危险因素与自我护理方法等方面的知识，患者及家属的足部护理等健康知识掌握度得以提高，激发患者的主观能动性，从而养成正确的习惯、形成专业的技巧，提高自我保健意识与行为能力。本研究结果显示，出院后1年，对照组血糖控制水平管理、足部及日常生活管理、病情监测管理评分低于出院时，观察组各项评分高于对照组；对照组空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血红蛋水平高于出院时，观察组低于对照组。分析原因：持续护理完善糖尿病足护理内容，持续进行用药自我管理指导，根据患者实际情况酌情调整饮食结构，确保患者营养均衡；积极疏导患者负性情绪，指导患者调整心态，提高患者依从性，因此血糖控制效果较理想。

综上所述，延续护理可提高糖尿病患者自我管理能力，有效控制血糖指标。

参考文献

[1] 吕婵.糖尿病足高危患者采用延续性护理对足部护理知识与患者自我管理能力的影响[J].糖尿病新世界,2019,22(18):162-163.

[2] 乔美娜,路潜,石潇洋,等.糖尿病患者足部护理行为测量工具的研究进展[J].重庆医学,2018,47(1):120-122.

[3] 中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J].中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409.

[4] 许华娇,黄建芬,沈英,等.上海市金山区2型糖尿病患者足部护理行为现状及其影响因素的分析[J].中国实用护理杂志,2019,35(27):2086-2090.

[5] 彭闵,许景灿,周秋红,等.基于个人与家庭自我管理理论的2型糖尿病患者足部自我管理行为的情境因素分析[J].解放军护理杂志,2019,36(2):27-31.

[6] 林伟,梅阳阳,林丽娜.延续护理干预对糖尿病足患者自我管理能力的影响[J].广西中医药大学学报,2019,22(1):91-94.

[7] 高娜,刘阳.糖尿病足患者自我管理行为量表的研制[J].护理研究,2016,30(4):1173-1180.